

УДК 614.2+364.4+159.9:61(574.41)

А. Г. Коровников¹, М. Н. Сандыбаев¹, Т. А. Адылханов²,
Т.И. Белихина¹, М.А. Мусульманова², Е.Ю.Колбина¹

¹Региональный онкологический диспансер города Семей

²Государственный медицинский университет города Семей

Опыт работы кабинета поддержки пациентов в составе службы медико-социальной и психологической помощи Регионального онкологического диспансера города Семей

Аннотация. Актуальной проблемой современной онкологии является сохранение качества жизни онкологических больных и повышение удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи. В данной статье показан опыт работы кабинета поддержки пациентов в составе службы медико-социальной и психологической помощи Регионального онкологического диспансера г. Семей. Проведенные специалистами службы мероприятия способствовали улучшению качества жизни и привели к повышению удовлетворенности пациентов и членов их семей оказываемой медицинской помощью, снижением числа жалоб в вышестоящие и контролирующие органы в 3,25 раза.

Ключевые слова: кабинет поддержки пациентов, качество жизни онкологических больных, удовлетворенность пациентов, психосоциальная помощь, кейс-менеджмент.

Достижения современной онкологии выдвигают на первый план задачу сохранения качества жизни (КЖ) онкологических больных. Значительное снижение КЖ обусловлено как самим онкологическим заболеванием, так и специальным лечением, а также психогенными реакциями, встречающимися у всех больных (Т.А. Адылханов) [1]. У онкологических больных в различные периоды развития патологического процесса появляются нарушения со стороны определенных органов и систем, ведущие к дезадаптации организма, ухудшению КЖ. Наличие и выраженность таких нарушений обусловлены как тяжестью и распространенностью онкологического заболевания, так и побочными эффектами и осложнениями специального лечения (хирургическое лечение, лучевая терапия, полихимиотерапия). В частности, это послеоперационные и постлучевые осложнения, побочные эффекты химиотерапии, осложнения гормональной терапии, психологическая травма как реакция на онкологический диагноз и проводимое лечение.

Онкологические больные находятся в серьезной стрессовой ситуации. Тяжелое соматическое заболевание, госпитализация, отрыв от привычного окружения, потеря социального статуса, возможность калечащей операции, нередко приводящей к инвалидности, угроза смерти — все эти факторы разрушают привычные стереотипы поведения, вырабатываемые в течение всей жизни, изменяют систему ценностей, перестраивают личность больного и ставят его перед проблемой адаптации к новым условиям.

Наличие у пациента тревожно-депрессивных и других психических нарушений является одним из важных факторов, препятствующих адаптации больного (А.Г.Коровников) [2 – с.25] и оказывающим негативное влияние на клиническую картину и течение большинства онкологических заболеваний (А. П. Пахомов и соавт. [3]. Они становятся причиной снижения уровня жизнедеятельности, сужения возможностей социальной и профессиональной реабилитации, формирования неадекватных представлений в отношении заболевания и лечения. Распространенность у онкологических больных коморбидных психических расстройств диктует крайнюю необходимость оказания им психологической и психотерапевтической помощи (О.В. Парамонова и соавт. [4].

Согласно W. Larbig (1998), цели психосоциальной помощи, направленной на повышение КЖ, состоят в том, чтобы помочь пациентам справиться с трудностями, связанными с болезнью и семейными проблемами, уменьшить или редуцировать связанные с заболеванием и терапией боль, условно-рефлекторную тошноту и рвоту, стресс, тревогу и депрессию, чувство беспомощности [5]. По мнению Парамоновой О.В. и соавт., одной из важнейших задач является формирование эффективной адаптации у данного контингента больных [4].

Также в настоящее время становится особенно актуальной проблема удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи. В условиях повышения правовой грамотности населения Республики Казахстан пациенты более настойчиво отстаивают свои права. Вследствие этого увеличивается число как обоснованных, так и необоснованных жалоб на медицинских работников. Следует иметь в виду, что жалобы являются косвенным показателем удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

В систематическом обзоре T. Reader с соавт. [6] по результатам анализа и кластеризации жалоб по причинам были выявлены следующие проблемные зоны:

- 1) менеджмент в организации здравоохранения (35,1%);
- 2) безопасность и качество оказания медицинских услуг (33,7%);
- 3) проблемы коммуникации пациента и работника здравоохранения (29,1%).

Удовлетворенность определяется не только, а, порой, и не столько уровнем проведения собственно медицинских пособий

и вмешательств, сколько их соответствием психологическим потребностям и субъективным ожиданиям больных. Roter et. al. [7] и Fritzsche K. et al. [8] описали условия, необходимые для удовлетворенности пациента:

- 1) тёплое, заботливое отношение;
- 2) сбалансированная связь по психологическим и биомедицинским аспектам беспокойства;
- 3) целостность отношений;
- 4) внимание, уделяемое беспокойству пациента.

В Региональном онкологическом диспансере г. Семей (РОД г.Семей) традиционно уделяется большое внимание вопросам качества жизни и психосоциальным аспектам онкологических заболеваний. Штатная должность врача-психотерапевта в нашем учреждении была введена в 1999 году впервые в Республике Казахстан.

С 2012 года в РОД г.Семей функционирует служба психосоциальной помощи, в состав которой вошли психолог и социальный работник. Данная служба занималась оказанием социально-психологической помощи пациентам онкологического диспансера и членам их семей. Врач-психотерапевт вошел в состав службы в качестве координатора.

В 2012 году общественным фондом «Твой выбор» (президент Токтаров К.Т.) совместно с РОД г.Семей и при поддержке Фонда Первого Президента открыт кабинет арт-терапии для онкологических больных. В специально оборудованном помещении под руководством психолога пациенты онкологического диспансера занимаются рисованием (изотерапия), вязанием, вышиванием, аппликацией, бисероплетением, лепкой, оригами и др. Применяются разнообразные методы классической и современной арт-терапии (терапии творческим самовыражением) с элементами трудотерапии. В кабинете созданы условия для проведения музыкотерапии, библиотерапии. Применение арт-терапии приводит к высвобождению подавленных эмоций, развитию творческих и коммуникативных способностей пациентов, мобилизации внутренних ресурсов организма на борьбу с болезнью.

В марте 2015 года в РОД г. Семей создан кабинет поддержки пациентов (КПП), оказывающий оперативную помощь больным и членам их семей в разрешении проблем и затруднений, возникающих в процессе обследования, лечения и диспансерного наблюдения. Работа данного кабинета способствует повышению удовлетворенности пациентов качеством оказанных медицинских услуг и снижению количества жалоб на медицинских работников.

В 2016 году с целью повышения эффективности психосоциальной помощи была проведена реорганизация и создана служба медико-социальной и психологической помощи (СМСИПП). Кабинет поддержки пациентов был введен в состав данной службы наряду с кабинетами психотерапии, арт-терапии и противоболевой терапии. Работа вышеуказанных структурных подразделений СМСИПП осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК № 452 от 02.08.2013 года «Стандарт организации оказания онкологической помощи населению РК» и Приказом МЗСР РК № 568 от 28.07.2016 года «Правила организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг».

Целью СМСИПП является оказание медико-социальной и психологической помощи пациентам и членам их семей с момента обращения в РОД и на всех этапах обследования, лечения и наблюдения с соблюдением принципов этапности и преемственности.

Перед службой поставлены следующие задачи:

1. Оказание консультативной помощи, предоставление информации по вопросам медицинской помощи, психологической и социальной поддержки пациентам РОД.
2. Оперативное разрешение конфликтных ситуаций и разработка мероприятий по их минимизации и профилактике.
3. Оказание психологической и, в сложных случаях, психотерапевтической помощи пациентам, членам их семей.
4. Консультирование по вопросам противоболевой терапии, организация и оказание помощи пациентам с разным уровнем болевых нарушений.

В процессе своей деятельности СМСИПП взаимодействует с иными структурными подразделениями РОД: советами, службами, комиссиями, а также с другими организациями и общественными объединениями региона и области.

В штат Кабинета поддержки пациентов введены следующие должности: координатор КПП (кейс-менеджер), социальный работник, психолог.

Кейс-менеджмент или социальное сопровождение – это координация профессиональных, социальных и медицинских услуг с целью оказания помощи людям с комплексными потребностями в долгосрочном уходе и защите. Данный вид социальной работы направлен на решение социальных проблем конкретного индивидуума, социального слоя или социальной группы [9]. В переводе с английского, «Case-Management» – это «управление в конкретном случае», «решение конкретной задачи». Кейс-менеджмент служит методическим способом соединения индивидуальной потребности клиента в помощи с находящейся в наличии социальной инфраструктурой. На точке пересечения между клиентом и такой инфраструктурой находится кейс-менеджер, призванный обеспечить оптимальное оказание помощи обратившемуся.

Целью КПП является повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи. Для ее достижения служат следующие задачи:

- 1) оперативное реагирование на обращения пациентов как лечебного, так и иного характера во взаимодействии с различными специалистами РОД;
- 2) систематизация работы по обращениям и жалобам пациентов;
- 3) проведение анализа и мониторинга поступающих обращений, корректировка процессов деятельности диспансера;
- 4) минимизация числа обращений (жалоб) пациентов на качество медицинской помощи в РОД;
- 5) улучшение социальной адаптации пациентов и членов их семей;
- 6) оказание психологической, психотерапевтической и психопрофилактической помощи пациентам и членам их семей.

В процессе работы КПП взаимодействует с другими структурами и специалистами диспансера, как показано на рисунке 1.

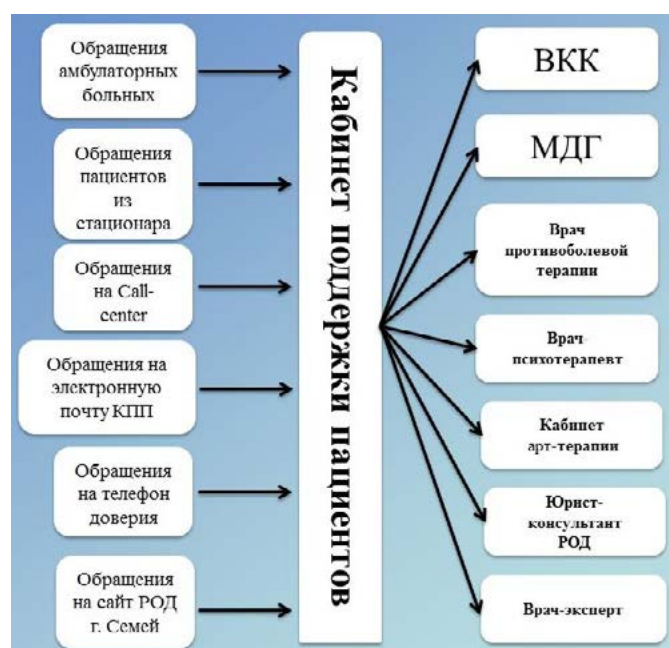


Рисунок 1 – Схема взаимодействия кабинета поддержки пациентов с другими подразделениями РОД г. Семей

Для удовлетворения зачастую комплексных потребностей пациентов и решения их проблем может понадобиться перенаправление их в другие организации и учреждения. Схема взаимодействия представлена на рисунке 2.

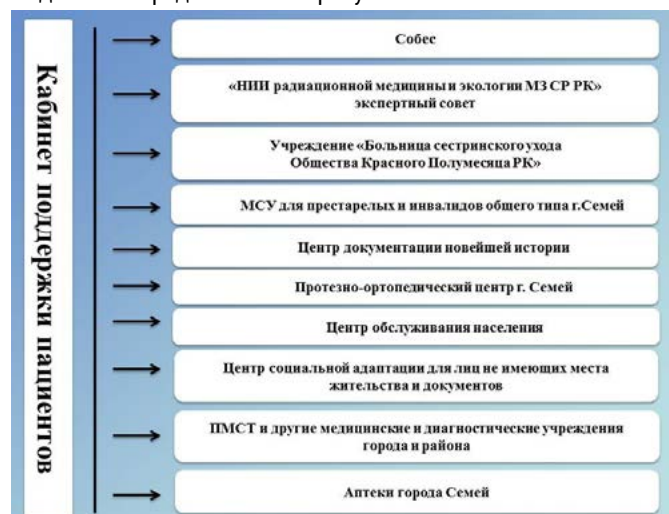


Рисунок 2 – Схема взаимодействия кабинета поддержки пациентов РОД г. Семей с другими учреждениями

За 9 месяцев 2016 года было зарегистрировано 1621 обращение в КПП, что в 1,7 раза превышает число обращений за 9 месяцев 2015 года. Рост числа обращений свидетельствует о повышении информированности пациентов и членов их семей об оказываемой кабинетом помощи и росте их доверия к службе. Повышение в 2,4 раза количества обращений по оказанию содействия в разрешении различных затруднений, возникающих у пациентов, также говорит о возрастающем доверии пациентов к специалистам КПП. Также в 2,4 раза вырос объем оказанной больным социальной помощи. Количество жалоб пациентов на ненадлежащее качество медицинских услуг снизилось в сравнении с прошлым годом в 3 раза, что является косвенным показателем роста удовлетворенности пациентов (рисунок 3).

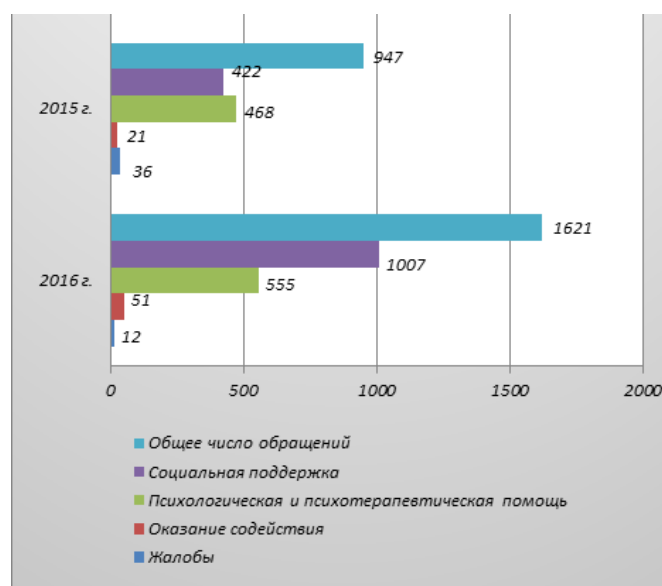


Рисунок 3 – Количество и характер обращений в кабинет поддержки пациент в апреле-декабре 2015 г. и в январе-сентябре 2016 г.

Как показано на рисунке 4, наибольший удельный вес в деятельности КПП занимает оказание социальной поддержки пациентам и их семьям (62%). Психологическая и психотерапевтическая помощь занимает 34%. Обращения с различными жалобами за 9 месяцев 2016 года составили в общей структуре обращений 0,8%. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года удельный вес жалоб в общей структуре обращений в КПП был в 4,8 раза выше и достигал 3,8%. Снижение объема работы с жалобами свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий по их профилактике.

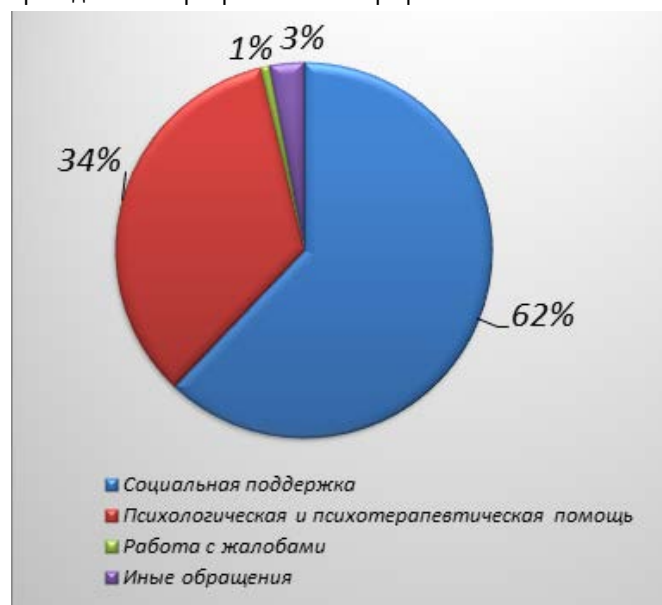


Рисунок 4 – Структура обращений в кабинет поддержки пациентов по итогам 9 месяцев 2016 года

Результатом активной работы КПП с 1 апреля 2015 года стало снижение числа жалоб в вышестоящие и контролирующие органы в сравнении с 2014 годом в 3,25 раза (рисунок 5). У пациентов РОД и их родственников, неудовлетворенных качеством медицинских услуг, появилась возможность обращаться со своими проблемами и претензиями непосредственно в КПП. После рассмотрения жалоб и разрешения конфликтных

ситуаций, удовлетворения потребностей пациентов у них отпадает необходимость обращения с жалобами в вышестоящие органы. Те пациенты или их законные представители, которые всё же обратились в контролирующие организации, не обращались в КПП. Как правило, после обращения в службу пациенты получают удовлетворение, и их жалобы не уходят за пределы диспансера.

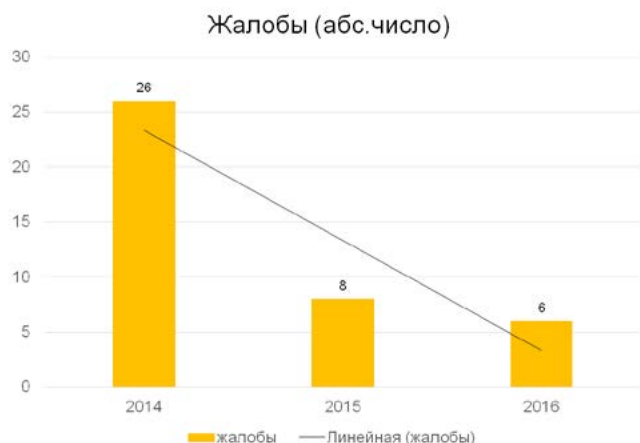


Рисунок 5 – Мониторинг жалоб пациентов РОД г. Семей в вышестоящие и контролирующие органы в 2014-2016 гг.

Косвенным подтверждением эффективности работы КПП по повышению удовлетворенности пациентов является также увеличение числа благодарностей специалистам РОД, направленных больными или их родственниками в вышестоящие органы с 4 в 2015 г. до 6 в 2016 году. При этом количество благодарностей специалистам КПП выросло в сравнении с прошлым годом в 3 раза (с одной благодарности в 2015 г. до трех в текущем году).

Выводы. Таким образом, нами показано, что работа кабинета поддержки пациентов в онкологическом диспансере способствует улучшению качества жизни и приводит к повышению удовлетворенности пациентов и членов их семей оказываемой медицинской помощью, снижением числа жалоб в вышестоящие и контролирующие органы в 3,25 раза.

Следовательно, имеющийся позитивный опыт эффективной работы кабинета поддержки пациентов в составе службы медико-социальной и психологической помощи в Региональном онкологическом диспансере г. Семей позволяет рекомендовать организацию кабинета поддержки пациентов в других учреждениях онкологического профиля Республики Казахстан.

Список литературы

1. Адылханов Т.А. Диагностика и дифференцированное хирургическое лечение рака молочной железы: дис.... докт. мед. наук. Астана, 2008.-163с.
2. Коровников А.Г. Повышение эффективности лечения больных раком молочной железы после радикального оперативного лечения в комплексе с психологической реабилитацией: дис.... канд. мед. наук. Астана, 2010.- 142 с.
3. Пахомов А. П., Петрова В.Д., Лазарев С.А. Психотерапия в онкологической практике – первый опыт // Инновации в онкологической практике. 65 лет онкологической службе Алтайского края. Мат. Российской научно-практической конф. с международным участием 14-15 июня 2011 года г. Барнаул / под ред. А.Ф. Лазарева. Барнаул: Азбука, 2011.- С.260-262.
4. Парамонова О.В., Петрова В.Д., Лазарев А.Ф. Коморбидные онкологическим заболеваниям психические расстройства и психотерапевтические подходы к их коррекции на амбулаторном этапе // Мат. Российской научно-практической конф. с международным участием 25-26 июня 2013 года г. Барнаул / под ред. д.м.н., профессора А.Ф. Лазарева.- Барнаул: Азбука, 2013.- С. 222-223.
5. Larbig W. Psycho-oncologic interventions – Critical review // Psychother. Psychosom. Med. Psychol.- 1998.- Vol. 48, № 9-10. – P. 381-389.
6. Reader T.W., Gillespie A., Roberts J. Patient complaints in healthcare systems: a systematic review and coding taxonomy // BMJ Quality & Safety.-2014.-Vol.23, № 8. – P. 678-689.
7. Roter D.L., Stewart M., Putnam S. M. et al. Communication Patterns of Primary Care Physicians // Journal of the American Medical Association. – 1997.-Vol. 277, № 4.- P. 350 – 356.
8. Fritzsch K., Armbruster U., Hartmann A., Wirsching M. Psychosocial primary care – what patients expect from their General Practitioners A cross-sectional trial //BMC Psychiatry.- 2002.- Vol. 2.- P. 5.
9. Дите В., Туреханов Я. и др. Рекомендации по организации программ социального сопровождения для уязвимых групп. Практическое пособие для социальных работников. AFEW, Алматы, 2007. – 160 с.

ТҰЖЫРЫМ

**А. Г. Коровников, М. Н. Сандыбаев, Т. А. Адылханов, Т.И. Белихина, М.А. Мусульманова,
Е.Ю.Колбина**

Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансері
Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті

**Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансерінің
медико-әлеуметтік және психологиялық қызмет
құрамында пациенттерді қолдау кабинетінің жұмыс
тәжірибесі**

Онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасын сақтау және пациенттердің көрсетіліп жатқан медициналық көмек сапасына көңілдері толуын арттыру бүгінгі онкологияның маңызды мәселесі болып табылады. Аталмыш мақалада Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансердің медико-әлеуметтік және психологиялық қызмет құрамында пациенттерді қолдау кабинетінің жұмыс тәжірибесі көрсетілген. Осы қызмет мамандарының жүргізген іс шаралары пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал етіп, пациенттер мен олардың отбасы мүшелерінің көрсетілетін медициналық көмекке көңілдері толып, қанағаттанушылығын арттырды, нәтижесінде жоғары тұрған және бақылаушы органдарға шағымдар саны 3,25 есеге азайды.

Түйінді сөздер: пациенттерді қолдау кабинеті, онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасы, пациенттердің қанағаттанушылығы, психоәлеуметтік көмек, кейс-менеджмент.

SUMMARY

A.G. Korovnikov, M.N. Sandybaev, T.A. Adylkhanov, T.I. Belihina, M.A. Musulmanova, E.Iu.Kolbina

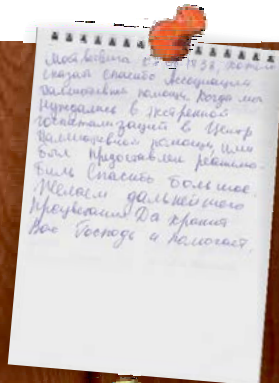
Regional oncology center of Semey
Semey State Medical University

**The experience of the patients support office at the social,
clinical and psychological service of the Regional oncology
center of Semey**

A protecting of the quality of life of oncology patients along with the raising of satisfaction of the medical care provided are actual problems of the modern oncology. The present article represents the experience of the patients support office at the social, clinical and psychological service of the Regional oncology center of Semey.

Activities, provided by specialists of the service, have contributed to life's quality improvement and improved the level of satisfaction of patients and their relatives by the medical care provided. Consequently, the numbers of complaints to the oversight authorities have decreased 3,25 times.

Keywords: patients support office, life's quality of the oncology patients, satisfaction of the medical care, psychosocial aid, case management.



Я дочь Карлоса Видуэра,
14.07.1932 г., р. в Бласко-де-
де-Пасе, Испания. После
эвакуации в лагерь в
Кадакз, затем в лагерь
Мельбурн. В лагере
была в числе тех, кто
был освобожден в
1945 г. и переехал в
Австралию. Сейчас живу
в Мельбурне. Хотела бы
получить данные Испания

[illegible]

Леди Сисели Сондерс- основательница первого в мире хосписа



АЛМАТЫ ОНКОЛОГИЯ ОРТАЛЫҒЫ
ALMATY ONCOLOGY CENTRE

8-800-080-5868

palliative.kz@gmail.com



КАТЕРЛІ ІСІКПЕН КҮРЕСЕЙІК
TOGETHER AGAINST CANCER
ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА
ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ • PUBLIC FUND • ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

- устранение или снижение болевого синдрома
- устранение или снижение других тяжелых симптомов болезни
- обучение навыкам ухода членов семьи
- психологическая и социальная поддержка
- помощь в транспортировке в Центр паллиативной помощи



Даша! Спасибо за то что
написали книгу про
Алго. Спасибо за то что
дали книгу, чтобы она
была с вами. Спасибо за то что
высказались так же как
ребенок. Спасибо! И так
на самом деле так
трудно писать! И так
много хочется сказать.



Даша! Спасибо за то что
написали книгу про
Алго. Спасибо за то что
дали книгу, чтобы она
была с вами. Спасибо за то что
высказались так же как
ребенок. Спасибо! И так
на самом деле так
трудно писать! И так
много хочется сказать.



Я Рубакина Мария
Михайловна, жена
Рубакина Игоря
Михайловича 1976 г.
Благодарю вас за
поддержку и помощь
в лечении и уходе.
Хотела бы сказать
представьте дамы
узнали, как так люди
в такие забавные
раки у нас есть
мне в душе
Благодарю вас за
поддержку.

30.11.2015
Благодарю за помощь
в лечении и уходе
за мной. Со мной
были Максимов Д.А.
сестра Татьяна
Александровна
матери, которая
стала мне
в душевной
мне помогать
моя мать
Благодарю вас за
поддержку!

Даша! Спасибо за то что
написали книгу про
Алго. Спасибо за то что
дали книгу, чтобы она
была с вами. Спасибо за то что
высказались так же как
ребенок. Спасибо! И так
на самом деле так
трудно писать! И так
много хочется сказать.

Все услуги предоставляются пациентам бесплатно. Данный проект осуществляется Фондом «Вместе против рака», при поддержке Фонда Сорос - Казахстан, Алматинского Онкоцентра и Управления здравоохранения города Алматы

